

03 - 03- Les hépatites aiguës et chroniques Partie 1 - Pr. Krati

(0:00 - 3:35)

Bonjour, les hépatites sont dues à des lésions nécrotico-inflammatoires des hépatocytes qui traduisent donc une souffrance hépatocytaire qui serait à l'origine d'une cytose. La nécrose hépatocytaire va entraîner la libération, donc va entraîner la libération des hépatocytes avec libération dans le sang des enzymes intra-hépatocytaires, les transaminases, donc c'est ce qui traduit dans la cytose. Les transaminases qui seront donc éliminées, les aminotransférases, on a deux types.

On a les aspartates aminotransférases qui ne sont pas spécifiques au foie parce qu'ils peuvent se libérer en cas de souffrance hépatocytaire, mais aussi lorsqu'on a des lésions de la cellule musculaire du cœur ou du muscle ou au niveau du rein, du cerveau, du pancréas au cou. Et par conséquent, leur augmentation ne permet pas de retenir ou d'être rattaché à une souffrance hépatocytaire. Par contre, les alanines aminotransférases, elles, elles sont spécifiques du foie et donc lorsqu'elles sont augmentées, on sait qu'il y a une lésion hépatocytaire.

Et ces hépatites peuvent être aiguës ou chroniques. Donc aiguë, en général, il y a de l'inflammation, de la nécrose et on ne trouve pas de fibrose. Ça traduit donc le caractère récent de la teinte aiguë et dans les hépatites chroniques, on va trouver de la fibrose.

Donc l'existence de la fibrose sur le plan histologique signe le caractère chronique de l'inflammation hépatocytaire et donc on parlera d'hépatite chronique. Donc sur le plan histologique, les hépatites aiguës se caractérisent par de l'inflammation hépatocytaire, par des lésions hépatocellulaires à type de ballonnisation de la nécrose. Il n'y a jamais de fibrose en cas d'hépatite aiguë.

Dans l'hépatite aiguë, l'inflammation est très importante et les lésions hépatocytaires sont très importantes. Ils sont avec une souffrance importante qui était à l'origine d'une cytolysse avec élévation des transaminases supérieure à 10 fois la normale, supérieure ou égale à 10 fois la normale et ce qui permet de retenir le diagnostic d'une hépatite aiguë. Bien sûr au cours de cette inflammation aiguë, au cours de cette souffrance hépatocytaire aiguë importante, il y a risque qu'il y ait une atteinte de la fonction hépatique et donc pour évaluer le pronostic et la gravité de cette souffrance ou de cette inflammation sur le foie, on a des critères qu'on appelle des critères de pronostic qui sont représentés par le taux d'albuminémie, par l'INR ou le taux de prothrombine.

(3:36 - 4:59)

Si ça en diminue, on sait que cette hépatite aiguë s'accompagne d'une atteinte, d'une insuffisance hépatocellulaire et qui est un critère de mauvais pronostic. Et c'est pour ça que devant une hépatite, lorsqu'on fait le diagnostic d'une hépatite aiguë, donc lorsqu'on trouve une cytolysse qui est supérieure à 10 fois la normale, il faut automatiquement rechercher l'étiologie parce que la prise en charge de l'étiologie permet de l'évolution de cette hépatite vers un mode

chronique et il faut en même temps préciser la gravité, donc le degré de l'insuffisance hépatocellulaire pour identifier les malades qui justifient une prise en charge dans une unité de soins intensifs avec éventuelle transplantation hépatique. Quelles sont les étiologies des hépatites aiguës? En fait, ils sont dominés par les hépatites médicamenteuses, en particulier le paracétamol, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, mais il faut savoir que tous les médicaments peuvent être à l'origine d'une hépatite aiguë et c'est pour ça que devant une hépatite aiguë, il faut savoir faire un listing de tous les médicaments pris par le patient.

(5:00 - 5:37)

Il y a aussi les hépatites toxiques, donc c'est pour ça qu'il faut rechercher en dehors des médicaments tous les produits toxiques que le patient aurait pu prendre. Il y a les hépatites alcooliques aussi, qui peuvent aussi donner des cytolyses aiguës. Et il y a les hépatites virales, donc A, B, C, D, E, qui sont des virus hépatotropes, mais aussi il y a des virus non-hépatotropes qui peuvent être responsables d'une hépatite aiguë chez des sujets immunodéprimés, comme le cytomegalovirus, l'Epstein virus, l'herpes simplex, etc.

(5:38 - 10:00)

Et il y a d'autres causes, donc le foie ischémique, qui peut se voir en cas d'un choc épouvolémique, lorsqu'il y a une hypoxie hépatique aiguë. Et on peut aussi avoir une cytolise en cas de migration de lithiase biliaire. Il y a d'autres causes aussi qui sont possibles et qu'il faut savoir rechercher.

La stéatose aiguë de la grosse échelle de la femme enceinte au troisième trimestre, amadouillante, les hépatites auto-humides, les origines vasculaires comme le ténosynovite de Butkari, qui est donc un obstacle sur les veines sus-hépatiques. Ça peut être un type de thrombose ou un envahissement ou une compression de ces veines. De toute façon, lorsqu'on fait le diagnostic d'une hépatite aiguë, il faut rechercher les étiologies et, en premier, il faut rechercher les hépatites médicamenteuses toxiques et virales.

Là, c'est un tableau qui résume les étiologies des hépatites aiguës. Et la deuxième, parallèlement à l'enquête étiologique, il faut évaluer la gravité. Donc, la gravité, c'est le degré de l'insuffisance hépatocellulaire.

Donc, il faut rechercher les signes d'insuffisance hépatocellulaire. Il faut rechercher en particulier les signes de non-céphalopathie hépatique. Déjà, il faut rechercher l'astérixis, la désorientation temporo-spatiale et les problèmes de concentration avant même l'installation du coma.

Et il faut mesurer l'insuffisance hépatocellulaire en recherchant une diminution de taux de prototombes ou du facteur 5. Ainsi, on définit les hépatites fulminantes par une insuffisance hépatocellulaire aiguë compliquée d'encéphalopathie dans les deux semaines suivant l'apparition de l'ictère. Et une hépatite subfulminante, elle est définie par une insuffisance hépatocellulaire

aiguë compliquée d'une encéphalopathie entre deux semaines et trois mois après l'apparition de l'ictère. Mais ce qu'il faut savoir que déjà, lorsqu'on a un taux de protocambules qui est inférieur à 50 ou un facteur 5 inférieur à 50, il faut savoir qu'on est devant une hépatite sévère et que le patient nécessite d'être hospitalisé en unité de soins intensifs.

L'évolution de l'hépatite aiguë se fait sur trois modes. Soit que le facteur étiologique a été contrôlé, à ce moment-là l'évolution va se faire vers la régénération hépatocytaire et une régénération efficace sans conséquences et c'est une évolution favorable. Soit que la souffrance hépatocellulaire a été tellement importante qu'elle a entraîné une insuffisance hépatique terminale qui nécessite une transplantation hépatique et en l'absence de celle-ci, le malade peut décéder.

On a le troisième mode d'évolution, c'est lorsque le facteur étiologique n'a pas été contrôlé et à ce moment-là l'évolution va se faire sur un mode chronique et ça se voit essentiellement avec les hépatites virales, les hépatites virales B, C, D. L'évolution de l'hépatite, comme je l'ai dit, se fait sur trois modes. Le mode favorable, le mode grave ou le mode chronique. Donc pour le mode favorable, généralement il y aura, après la phase inflammatoire, il y aura donc un nettoyage de toutes les lésions lésées, il y aura une prolifération hépatocytaire qui va remplacer les cellules mortes et ce sera donc un foie normal.

(10:00 - 13:00)

Si l'inflammation et la nécrose étaient tellement importantes qu'elle a entraîné l'insuffisance hépatocellulaire sévère, donc c'est le décès du patient. Et le troisième mode, c'est le mode chronique. Dans ce mode, il va se mélanger, il y a persistance d'abord de la cause de l'hépatite, ce qui va entraîner persistance de lésions hépatocytaires.

À ce moment-là, on aura de l'inflammation avec de la fibronogénèse qui va évoluer et cette inflammation et fibronogénèse peut évoluer dans le temps et aboutir à une cirrhose avec ces complications. Les hépatites chroniques se caractérisent par une évolution des anomalies supérieures à 6 mois et sur le plan histologique, elles se caractérisent par l'existence de l'inflammation et de la fibrose. Et la gravité de les hépatites chroniques est liée au degré de fibrose, au degré de la sévérité de la fibrose et donc au risque de survenue de cirrhose.

Donc sur le plan histologique, les hépatites chroniques, il y a de l'inflammation mais il y a de la fibrose et cette fibrose témoigne de l'évolution prolongée des lésions histologiques. Donc l'hépatite chronique survient après une phase aiguë d'hépatite qui est souvent pas inaperçue. Et l'hépatite chronique est peu symptomatique ou se manifeste par des signes peu spécifiques.

Et souvent l'examen clinique est normal. Malheureusement, cet aspect donc post-symptomatique des hépatites chroniques fait que souvent le diagnostic est fait à un stade plus tardif, au stade de cirrhose ou d'une complication de cirrhose. À ce moment-là, c'est un petit peu trop tard parce que la gestion des complications de la cirrhose est difficile et parfois impossible.

Par contre, lorsqu'on porte le diagnostic avant l'installation de la cirrhose, de l'hépatite chronique, c'est très important de rechercher l'étiologie. Pourquoi rechercher l'étiologie? Parce qu'en diagnostiquant l'étiologie, on va proposer un traitement et on va arrêter l'évolution vers la cirrhose. Ça d'une part.

(13:00 - 17:31)

De l'autre part, il faut toujours évaluer la sévérité, donc définir le stade d'évolution de l'hépatite chronique en évaluant sur le plan histologique le degré de la fibrose, la sévérité de la fibrose. Et aussi en recherchant des signes indirects d'une cirrhose comme l'insuffisance hépatocellulaire ou des signes d'hypertension. Pour résumer, lorsqu'on diagnostique une hépatite chronique, il faut toujours rechercher sa cause et évaluer sa gravité.

Et sa gravité est liée au degré de la sévérité de la fibrose. Pour le diagnostic étiologique, sur le plan biologique, les hépatites chroniques se caractérisent par des transaminases élevées, mais qui ne dépassent pas généralement du foie à la normale. Et les causes les plus fréquentes restent les hépatites chroniques, les hépatites auto-immunes, l'éthylisme, c'est-à-dire l'hépatite alcoolique, l'hépatite médicamenteuse ou des hépatites liées à un déficit en alpha-antithréoxine, une stéatose, donc les autres causes qui sont plus rares.

Deuxième chose, il faut évaluer la gravité, donc c'est évaluer la sévérité de la fibrose qui est le critère de gravité le plus important. Et le degré de la fibrose dépend de l'évolution de la maladie. Donc il faut savoir que la fibrose peut être discrète, limitée aux espaces portes ou périportales, quand il peut envoyer des septa vers le lobule, on parle dans ce cas d'une fibrose septale, et parfois il peut être sévère, intéressant tout le lobule en limitant des nodules et on est au stade 2 sur 1. Il y a plusieurs scores et là c'est le score de Metavir, ce score il définit la fibrose F1 lorsque la fibrose est uniquement périportale.

On parle de fibrose F2 lorsque la fibrose émet des septa vers le lobule, on parle de F3 lorsque ces septa vont limiter des petits nodules mais de façon limitée, ils vont faire des pans entre eux, lorsqu'il y a des pans entre les différents septa de fibrose et lorsque cette fibrose devient extensive avec des nodules de régénération, avec des organisations de l'architecture vasculaire, on parle d'un F4. Comment évaluer les lésions hépatiques, c'est-à-dire en particulier la fibrose ? Déjà, ou autrefois, on n'avait que la ponction glussée hépatique qui est un examen invasif qui permet donc d'évaluer l'activité inflammatoire et le degré de la fibrose grâce à des scores de métavires que j'ai déjà cités. Mais il faut savoir que cette ponction, comme je l'ai dit, est invasive, donc pour la faire, il faut avoir un ballon de moustache normal, des plaquettes normales, il faut qu'il n'y ait pas de lésions de dilatation au niveau des veilles intra-hépatiques, pas de lésions, pas d'angiome, donc là on peut faire une ponction glussée hépatique transparitale.

(17:32 - 22:33)

Par contre, si le bullon de moustache ne le permet pas, donc il faut faire une ponction glupsée hépatique par voie transjugulaire. Et si on a des lésions localisées au niveau du foie, comme un angiome excratique ou autre, là il faut faire une ponction glupsée hépatique transparitale, mais éco-guide. La ponction glupsée hépatique a certaines complications, rares mais elles existent, c'est pour ça qu'elle n'est pas acceptée par tous les patients.

Et comme je l'ai dit, il reste un examen invasif, ce qui a amené à rechercher d'autres examens non-invasifs qui peuvent aussi évaluer la fibrose. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas évaluer toujours l'activité, mais ils peuvent évaluer la fibrose quand le fibrotest, qui est basé sur des examens qui vont poser les gamma-gt, les transaminases, donc des marqueurs biologiques, et à partir de ces marqueurs, il va déterminer le degré de la fibrose. Il y a aussi le fibroscan.

Le fibroscan, c'est un test qui va permettre de mesurer l'élasticité du foie. Et en fonction de la dureté du foie, il va évaluer le degré de la fibrose. Actuellement, le plus souvent, on a recours à ces tests non invasifs.

Donc, la ponction du cépatite, on va la réaliser que lorsqu'on cherche un facteur étiologique. Il va nous aider, en plus de l'évaluation de la fibrose, sur l'origine de cette hépatite chronique. Donc, la gravité des hépatites chroniques est liée au degré de la sévérité de la fibrose.

C'est pour ça que lorsqu'on diagnostique l'hépatite virale chronique, on évalue la sévérité de la fibrose. Mais il faut aussi chercher les facteurs qui peuvent accélérer la vitesse de progression de la fibrose pour pouvoir aussi les traiter, éviter cette accélération de la survenue de la cirrhose. Et parmi les facteurs qui accélèrent la vitesse de progression de la fibrose, c'est déjà, bien sûr, le facteur étiologique qui va être à l'origine et à la persistance de l'inflammation de la nécrose.

Mais aussi certains facteurs qui agissent comme des facteurs synergiques. Par exemple, la co-infection de deux causes d'hépatite chronique. Une hépatite virale B et une hépatite virale C. Une hépatite virale B et l'alcool.

Une hépatite virale avec un syndrome avec une surcharge en fer. Une hépatite virale et une stéatose hépatique. Donc, l'effet synergique de deux facteurs étiologiques, lorsqu'on a deux facteurs, deux causes d'hépatite chronique, peuvent avoir un effet synergique et accélérer l'évolution vers la cirrhose.

Il faut savoir que la fibrose est de lésion irréversible. Donc, il faut diagnostiquer précocement les hépatites chroniques et traiter, proposer un traitement rapide avant l'installation d'une fibrose expansible irréversible. Il y a aussi un facteur qui est lié à l'individu.

C'est sa prédisposition génétique pour accélérer la vitesse de progression de la fibrose. Je citerai par exemple l'homme. Chez l'homme, l'hépatite virale C, l'évolution vers la cirrhose se fait plus rapidement que chez la femme.

Donc, tous ces éléments-là, il faut les identifier lorsqu'on fait le diagnostic de la cirrhose. Et il faut donc éviter ou proposer une prise en charge qui évite cette progression rapide vers la cirrhose. La hantise des hépatites chroniques, je l'ai dit depuis le début, c'est la survenue de la cirrhose parce que la cirrhose expose à une insuffisance hépatocellulaire chronique, expose au risque de survenue d'une hypertension portale, qui peut entraîner un hémorragie digestif par rupture de varices oesophagiennes et peut être mortelle.

(22:33 - 22:53)

Il peut entraîner une insuffisance rénale aiguë. Il peut entraîner aussi un syndrome hépatopulmonaire, favoriser l'encéphalopathie, l'acidose métabolique. Donc, ça retentit sur la qualité de vie, mais aussi sur le pronostic.

(22:53 - 23:43)

Il y a aussi le risque de survenue de carcinomes hépatocellulaires, qui est une complication grave de la cirrhose et donc des hépatites chroniques. Pour conclure, je dirais que les hépatites aiguës chroniques restent graves, fréquents, peuvent constituer un problème de santé publique. D'où l'intérêt de les connaître et surtout de connaître leur étiologie et de prévenir leur survenue, en particulier les hépatites d'origine virale, car les moyens de prévention peuvent nous éviter la survenue de ces hépatites et nous éviter la survenue de la cirrhose, qui est une complication fatale des hépatites chroniques.

(23:44 - 23:44)

Je vous remercie.